リハ医療デイリー

REHA MEDICAL DAILY

2026年10月29日（木）

第48号　朝刊

きょうの紙面　▶回復期×医療AI　▶大腿骨近位部骨折　▶脳卒中・作業療法　▶短信 8本

■ 回復期×医療AI

リハ記録から言語モデルがFIMを推定
推定できたのは3割、77.7%が±1点

日本の回復期病院のPT・OT・STノート5年分

ＦＩＭは正式な評価が一定の間隔でしか行われない一方、日々のリハ記録には機能の様子が書かれている。済生会守山市民病院で２０１９年１０月～２０２４年９月に入院した脳梗塞、大腿骨骨折、椎体骨折の患者について、ＰＴ・ＯＴ・ＳＴの自由記載ノートを院内の言語モデルに読ませ、項目別に推定させた。

ノートと項目の組み合わせは約２９５万件で、有効な推定が出たのは９８万件（３３・２％）。同日の基準ＦＩＭがある１７万件余りのうち推定できた５７，２４６件（３３・５％）では、７７・７％（４４，４８１件）が基準値の±１点以内に収まった。平均絶対誤差は０・８２５で、直前の値を持ち越す単純な方法（０・６４８）より大きかった。ＯＴノートの推定は、脳梗塞と大腿骨骨折でＰＴノートより誤差が小さかった。

単施設の後ろ向きで、外部検証はこれからだ。評価の代わりではなく、評価と評価の間を記録で補う試みで、動作の書き方が使える情報量を左右する。



記録からFIMを推定する

出典 JMIR Med Inform ↗

数字で見る

33.2%
推定できた割合

77.7%
基準FIMの±1点以内

0.825
平均絶対誤差（持ち越し0.648）

■ 大腿骨近位部骨折

手術の遅れは理由で死亡に差
全身状態待ちは30日OR3.57

英国の１施設で２０２０年３月～２０２４年１２月に治療した６０歳超の大腿骨近位部骨折１，７６９人を調べたコホート研究。手術までの時間と遅れた理由を記録した。最多の理由は手術室の空き不足（３６５人、２０・６％）で、全身状態の安定待ちが１０２人（５・８％）だった。

手術室の都合だけの遅れは、３０日死亡（ＯＲ０・７８４）にも１年死亡（ＯＲ１・１２３）にも差がなかった。全身状態の安定待ちは３０日死亡ＯＲ３・５７３、１年死亡ＯＲ２・１４４と高かった。状態の悪い人ほど安定待ちになりやすく、遅れそのものが原因とは言えない。著者は術前の全身管理が要点とする。



出典 Injury ↗

■ 脳卒中・作業療法

脳卒中後のレジャー参加の支援
評価105種のうち専用は7つ

オーストラリアで、脳卒中後のレジャー（余暇活動）への参加をどう評価・介入しているかを、臨床家１３１人にオンラインで尋ねた。回答者はＯＴとＰＴが各３５％、ＳＴが１８％。使われた評価は１０５種で、レジャー専用の項目や尺度を含むのは７つだけだった。

介入は上肢（４４％）や移動（４４％）の機能への働きかけ、活動の調整（５４％）が中心で、障壁は予算、研修、資源の不足。ガイドラインを参照しても余暇のリハの判断材料にはならず、個々の臨床推論に頼っていると著者は述べる。自己申告の横断調査で、日本への当てはめには注意が要る。



出典 Disabil Rehabil ↗

短信

〈メタ解析〉 **ウェアラブル活用の心臓リハ**

１８ＲＣＴ・１，９９３人。６分間歩行は+３１・０mだが、予測区間は-６２～+１２３mで０をまたぐ。

出典 JMIR mHealth Uhealth ↗

〈後ろ向きコホート〉 **骨折の部位と要介護度の関連**

静岡の請求データ１４・６万件。橈骨遠位は要介護認定なしが８６％、大腿骨近位は４７％。 出典 Age Ageing ↗

〈横断研究〉 **潜在性脳梗塞と遂行機能**

地域高齢者６５２人。潜在性脳梗塞は１０％で、遂行機能障害のＯＲ ２・３９。因果は不明。 出典 Hypertens Res ↗

〈RCT〉 **高齢者の身体拘束を減らす**

中国ＩＣＵの４８５人。せん妄・昏睡なし日数は差なし。人工呼吸器離脱日は+０・６９日。 出典 JAGS ↗

〈系統的レビュー〉 **脳卒中の遠隔リハ満足度**

１９研究・８１１人。満足度は高いが、満足度を主要評価にした研究は一つも無い。 出典 Cerebrovasc Dis ↗

〈系統的レビュー〉 **フレイルへの栄養と運動**

１０ＲＣＴ。運動でフレイル改善（逆転オッズ２～５倍）。栄養の上乗せ効果は不明。 出典 Nutr Health ↗

〈後ろ向きコホート〉 **呼吸リハの4象限分類**

慢性呼吸器疾患９３４人。１０週で全象限が改善、１年後は減衰。対照群はない。 出典 Respir Med ↗

〈質的研究〉 **痙縮ケアの利用者の声**

痙縮外来の利用者・介護者１２人。連携の分断と理解不足を指摘。一般化はできない。 出典 Disabil Rehabil ↗